



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**TOR
PELATIHAN PENYIAPAN OBAT INTRAVENA
DAN
TEKNIK ASEPTIK**

TAHUN 2025

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



TOR
PELATIHAN PENYIAPAN OBAT INTRAVENA DAN
TEKNIK ASEPTIK
TAHUN 2025

I. LATAR BELAKANG

Menurut USP edisi ke 34, compounding adalah penyiapan, pencampuran, perakitan, pengubahan, pengemasan dan pelabelan obat, perangkat pengiriman obat, atau peralatan sesuai dengan resep dokter, pesanan obat, atau inisiatif berdasarkan pada hubungan praktisi-pasien-apoteker-compounder dalam hubungan praktek profesional. Compounding dilakukan karena dosis yang ada di pasaran tidak tersedia, adanya perubahan bentuk sediaan dari sediaan padat ke cair atau sebaliknya, untuk mengkombinasikan bahan (karena tidak tersedia di pasaran), adanya reaksi atau alergi dari bahan yang terkandung dalam suatu produk. Prinsip umum dari kegiatan ini adalah personel harus terlatih dan memenuhi kualifikasi untuk mampu melakukan tugas yang diberikan, peralatan yang digunakan harus benar, dan area compounding harus sesuai untuk mencegah kontaminasi silang.

Pencampuran sediaan steril atau dispensing sediaan steril merupakan rangkaian perubahan bentuk obat dari kondisi semula menjadi produk baru dengan proses pelarutan atau penambahan bahan lain yang dilakukan secara aseptis oleh apoteker di sarana pelayanan kesehatan. Menurut Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, pencampuran sediaan steril ini harus dilakukan secara terpusat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang dilengkapi laminar airflow cabinet dan petugas sudah terlatih dengan Teknik aseptik serta menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk menghindari infeksi nosokomial, kontaminasi sediaan, paparan terhadap petugas dan lingkungan, mencegah risiko kesalahan terkait penggunaan sediaan obat dan untuk menjamin kualitas mutu sediaan.

Pelayanan Dispensing sediaan steril ini merupakan pelayanan yang penting untuk dilakukan instalasi farmasi. Pelayanan ini bertujuan untuk manajemen terapi dan meningkatkan kualitas dari pelayanan serta mengurangi resiko yang mungkin terjadi seperti resiko kontaminasi mikroba, resiko kontaminasi partikel, menjamin ketepatan pengenceran, menjamin stabilitas dan kompatibilitas, menjamin kesesuaian rute dan laju administrasi serta mengurangi kesalahan penggunaan dari obat-obatan.

Penggunaan dari obat-obatan ini juga harus diperhatikan, karena selain dapat memberikan kesembuhan obat dapat pula membahayakan diri sendiri apabila pengelolaan tidak sesuai dengan aturan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit obat-obatan yang perlu diwaspadai (High Alert Medications) adalah obat yang sering menyebabkan terjadi kesalahan/kesalahan serius (sentinel event) apabila, obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan (adverse outcome) seperti obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapanm Mirip/NORUM, atau Look Alike Sound Alike/LASA), elektrolit konsentrasi tinggi (misalnya kalium klorida 2meq/ml atau yang lebih pekat, kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0,9%, dan magnesium sulfat = 50% atau lebih pekat), serta obat-obat sitostatika.

Cara yang paling efektif untuk mengurangi atau mengeliminasi kejadian tersebut adalah dengan meningkatkan proses pengelolaan obat-obat yang perlu diwaspadai termasuk memindahkan elektrolit konsentrat dari unit pelayanan pasien ke farmasi. Rumah Sakit secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan atau prosedur membuat daftar obat-obat yang perlu diwaspadai berdasarkan data yang ada di Rumah Sakit Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, Kabupaten Pasuruan merupakan instansi kesehatan yang terus berusaha memberikan pelayanan kesehatan maksimal bagi masyarakat di wilayah Pasuruan dan sekitarnya. Dalam memberikan pelayanan maksimal, diperlukan pemahaman secara mendalam dan seragam tentang pelayanan kesehatan baik oleh staf medis maupun non medis. Hal ini bertujuan agar pasien mendapatkan pelayanan dengan kualitas yang sama



serta dapat mendukung keselamatan pasien. Untuk dapat memberikan pelayanan maksimal tersebut perlu adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia agar dapat menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mengadakan Pelatihan Compounding Sediaan Steril, Teknik Aseptik dalam Pencampuran Obat dan Pentingnya Pengelolaan Obat High Alert guna menjamin keseragaman, Pengelolaan, mutu, manfaat dan khasiat obat yang disiapkan sebelum diserahkan kepada pasien serta dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang maksimal terhadap pasien, keluarga pasien maupun pengunjung.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. PMK no 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKE/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

III. Maksud dan Tujuan

a. TIU

Tujuan diadakan pelatihan ini adalah agar seluruh PPA di Rumah Sakit dapat mengetahui dan menerapkan standar serta prinsip-prinsip dasar compounding sediaan non-steril, teknik aseptik dalam pencampuran obat dan pentingnya pengelolaan obat high alert secara seragam.

b. TIK : jika sasaran pesertanya dokter maka

1. Memberikan pemahaman secara seragam kepada seluruh staf PPA dalam pelaksanaan compounding sediaan non-steril, teknik aseptik dalam Pencampuran Obat dan Pentingnya Pengelolaan Obat High Alert yang benar sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi PPA mengenai compounding sediaan non-steril, Teknik Aseptik dalam Pencampuran Obat dan Pentingnya Pengelolaan Obat High Alert yang benar sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan terkait compounding sediaan non-steril, Teknik Aseptik dalam Pencampuran Obat dan Pentingnya Pengelolaan Obat High Alert

IV. Rencana Rapat Panitia Penyelenggara

Stunting (Tema)								
Judul Materi	Sasaran	Narsum	Metode	Perlengkapan	Frekuensi	Dasar Materi	Output Training	Goal Training Jangka Panjang
penyiapan obat intravena dan Teknik aseptik	Perawat Bidan	apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm	Pre post test Presentasi Diskusi kasus Praktek	LCD Laptop Google Form Pre post test Vial Antibiotic Sput 10cc Ns 0,9% 100cc Handscoon - nonsteril Tissue	1x / tahun	Regulasi, pengertian dan tujuan Jenis-jenis sumber kotaminasi Permasalahan penyiapan sediaan iv Persyaratan sediaan iv Prinsip pencampuran obat Teknik rekonstitusi serbuk via, larutan obat ke sediaan infus <i>Expired Date (ED) dan Beyond Use Date (BUD)</i> Stabilitas obat	Kenaikan nilai post test terhadap pre test Paham penyiapan obat intravena dan Teknik aseptik Mampu melakukan penyiapan obat intravena dan Teknik aseptik dengan baik dan benar	Regulasi terkait penyiapan obat intravena dan Teknik aseptik

Format Outline Training

No.	Outline	Isi PPT	PJ
1	Barcode absensi	QR code absensi	Novia Ainur Pratiwi, S.KM
2	Pre test	QR code pre test dengan waktu (estimasi 30 detik / pertanyaan)	Novia Ainur Pratiwi, S.KM
3	Susunan acara	Tabel rundown acara training	Novia Ainur Pratiwi, S.KM
4	Judul	penyiapan obat intravena dan Teknik aseptik	apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm
5	Latar belakang	Permasalahan penyiapan sediaan iv :sterilitas (kontaminasi), stabilitas, dan kompatibilitas	apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm
6	Goals	1. Menjamin agar pasien menerima obat sesuai dengan dosis yang dibutuhkan 2. Menjamin stabilitas dan sterilitas produk 3. Melindungi petugas dari paparan zat berbahaya 4. Menghindari terjadi kesalahan pemberian obat	apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm
7	Prinsip pencampuran obat	1. Persyaratan sediaan iv (compatible dan incompatible) 2. Persiapan (alat dan bahan, peralatan, ruangan/ lingkungan, APD dan petugas) 3. Teknik rekonstitusi serbuk via, larutan obat ke sediaan infus	apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm
8	<i>Expired Date</i> (ED) dan <i>Beyond Use Date</i> (BUD)	Pengertian <i>Expired Date</i> (ED) dan <i>Beyond Use Date</i> (BUD)	apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm
9	Stabilitas obat	Pengertian dan contoh kasus pencampuran obat yang compatible dan inkompabilitas	apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm
10	Diskusi	1. Tanya jawab terkait materi 2. Kesulitan-kesulitan yang selama ini dialami di lapangan terkait penyiapan obat intravena dan Teknik aseptik	apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm Moderator : apt. Ledyna Astri Oktasari, S.Farm
11	Kesimpulan	Penekanan pada hal-hal yang harus dilakukan setelah ini	apt. Ledyna Astri Oktasari, S.Farm
12	Post test	QR code post test dengan waktu (estimasi 30 detik)	Novia Ainur Pratiwi, S.KM
13	Role play	<i>compounding</i> sediaan non- steril dengan teknik aseptis	Peserta pelatihan

Rapat : Pre Training : Materi / bahasan saat rapat calon panitia penyelenggara

No	Bahasan dan Kegiatan	PJ	Yang terlibat / yang masuk Panitia
1	Mendiskusikan materi yang akan diberikan untuk training (materi berdasarkan outline training)	apt. Laili Choirul Umma, S.Farm	Semua yang terkait TIM/Komite/PJ Program/PJ Bab dan yang harus dilibatkan

2	Pembuatan soal pre/post test dan kunci jawaban penilaian praktek oleh instruktur kompeten kalau perlu dilakukan TOT Lebih dulu	apt. Ledyna Astri Oktasari, S.Farm	
3	Tentukan siapa NS yang harus membuat PPT berdasarkan kisi-kisi materi yang sudah didiskusikan	apt. Laili Choirul Umma, S.Farm	Panitia narasumber
4	Pengumpulan PPT materi maksimal H-7 acara	apt. Laili Choirul Umma, S.Farm	Narasumber
5	Menentukan moderator training (pilih SDM yang menguasai program tersebut atau yang bisa mengendalikan acara bisa dirangkap MC)	apt. Ledyna Astri Oktasari, S.Farm	Kabid Yan Med/PT/Ketua komite
6	Menyusun panitia (MC merangkap dokumentasi, IT sebagai operator)	apt. Ledyna Astri Oktasari, S.Farm	Tim/Komite/PJ Program/Pj Bab akre, keuangan
7	Membuat / membahas Form Evaluasi untuk penyelenggara untuk narasumber	apt. Ledyna Astri Oktasari, S.Farm	Tim/Komite/PJ Program/PJ Bab Akre, dll
8	Media apa saja yang perlu disiapkan agar diklat berjalan sesuai tujuan dan harapan	apt. Ledyna Astri Oktasari, S.Farm	Tim/Komite/PJ Program/PJ Bab Akre, dll
9	Penyusunan slide host (PPT yang ditampilkan sejak awal mulai dari absensi, pre test, rundown, ppt materi, posttest dijadikan 1 kesatuan)	apt. Ledyna Astri Oktasari, S.Farm	Panitia

3.1 Monitoring : (proses dalam kegiatan / durante acara)			
No	Bahasan dan kegiatan	PJ	Yang terlibat/ yang masuk panitia
1	Memastikan training berjalan sesuai TOR dan rundown	apt. Laili Choirul Umma, S.Farm	PJ Training
2	Mencatat evaluasi yang ditemukan selama training berjalan	apt. Ledyna Astri Oktasari, S.Farm	PJ Training, Ketua Komite terkait
3	Memimpin evaluasi setelah training selesai	apt. Laili Choirul Umma, S.Farm	PJ Training, Ketua Komite terkait
4	Mengirimkan link g-form evaluasi yang diisi oleh narasumber	apt. Ledyna Astri Oktasari, S.Farm	Narasumber
5	Menyiapkan kredensial apabila materi training ada sesi praktek / role play	apt. Dita Nurul Aini, S.Farm	Ketua Komite terkait

3.2. Evaluasi (Post Training) jangka pendek			
1	Merekapitulasi hasil nilai pre test post test dan praktek dan dibahas sebagai evaluasi apakah sesuai target? Ataukah ada yang perlu mengulang	apt. Ledyna Astri Oktasari, S.Farm	Panitia
2	Melakukan evaluasi hasil penilaian baik untuk penyelenggara maupun untuk narasumber dan pengamatan perilaku peserta saat diklat (serius, mengantuk, antusias)	apt. Laili Choirul Umma, S.Farm	Panitia

3	Menerbitkan sertifikat	apt. Laili Choirul Umma, S.Farm	SDM
4	Evaluasi kinerja panitia	apt. Laili Choirul Umma, S.Farm	Panitia

Evaluasi (Post Training) jangka panjang			
1	Melakukan supervisi atau observasi kepatuhan peserta diklat terhadap regulasi dan materi-materi dalam diklat yang sudah diikuti. (apakah staf sudah terampil sesuai goal / outcome yang diharapkan dari pelaksanaan diklat?)	apt. Laili Choirul Umma, S.Farm	SDM dan Tim/Komite/PJ Program/PJ Bab Akre, dll
2	Hasil tersebut di No. 1 dibahas di rapat koordinasi	apt. Laili Choirul Umma, S.Farm	Tim/Komite/PJ Program/PJ Bab Akre, dll
3	Buat RTL-TL-Evaluasi terus menerus	apt. Ledyna Astri Oktasari, S.Farm	Tim/Komite/PJ Program/PJ Bab Akre, dll

Kebutuhan Anggaran					
No.	Rincian Kebutuhan	Jumlah	Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Sumber Dana
1	Snack pematik	2	RP	Rp	Dapur RSPHS
2	Aqua botol	2	Rp	Rp	Dapur RSPHS
3	Aqua gelas	2 box	Rp	RP	Dapur RSPHS
4	Sertifikat	20	RP 0	Rp 0	SDM
Total				Rp 0	
Yang diajukan kepada PT Disa Prima Medika				Rp 0	

VIII. MONEV

Monitoring dilaksanakan saat persiapan, pelaksanaan, dan pembuatan pelaporan serta aplikasi lapangan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak.

IX. PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Untuk mempertahankan nilai Akreditasi Rumah Sakit yang Paripurna. Oleh karena itu dukungan semua pihak sangat penting dalam keberhasilan acara ini.

Kepala SDM & Diklat

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Novia Ainur Pratiwi, S.KM

Pasuruan, 2 Desember 2025
Ketua Panitia

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

apt. Laili Choirul Umma, S.Farm

Disetujui,



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep